EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	87679
SERVICIO	:	UNIDAD EMERGENCIAS			
FECHA	:	2024-07-02 10:00:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA GRACIELA GATICA URIBE			RUN	: 7.692.648-4
F.Nac	: 02-03-1954	Edad	: 70 AÑOS, 4 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: SAN CARLOS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: PARTICULAR	Teléfono	: 949020094		
Fecha Ingreso	: 01-07-2024	Fecha Egreso	: 2024-07-02 10:00:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. C76-C80-TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUN

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Encefalopatía multifatorial
-ITU
-Melanoma con MTT cerebrales, pulmonares y oseas, en Cuidados Paliativos
-Epilepsia 2° a MTT cerebrales
-Obs leucoencefalopatía 2° a RTx craneal
-Obs ACV isquémico

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente en REG, HDN estable, afebril, eupneica, levemente más reactiva que ayer, discreta mayor fluencia verbal, mantiene sopor leve, impresiona sin dolor.
TC cerebro s/c de ingreso y de control muestran edema supratentorial izquierdo a nivel de centro semioval (lugar de ambas mtt cerebrales) con leve foco hemorrágico y calcificado frontal mesial ipsilateral (estable), y microangiopatía supratentorial Fazekas 3.
AngioTC cerebro y cuello sin signos de vasculopatía.
Exs de lab destaca PCR 50, sin leucocitosis, OC compatible con ITU, fx renal y ELP normales.
Cuadro actual impresiona encefalopatía 2° a enfermedad médica (ITU), edema vasogénico cerebral 2° a mtt, RAM (PGB, morfina, metadona), posible estado postictal y encefalopatía Wernicke (hipoalimentación de larga data).
Evaluación fonoaudiológica concluye paciente apta para inicio de régimen papilla
En vista de la condición de la paciente dada por el avance de su enfermedad de base, se decide en conjunto con hija cuidadora, inicio de de ATB EV empírico (urocultivo pendiente para ajuste de dosis), IC a HODOM para administración de ATB, aumento de dosis de LVT y dexametasona, inicio de cotrimoxazol profiláctico y tiamina EV, con alta a domicilio el 2/7/24, continuar controles con equipo de Cuidados Paliativos y control en policlínico de Neurología en 10-12 días.

INDICACIONES AL ALTA

1. -Levetiracetam 500 mg 3 comp c/12 horas
2. -Dexametasona 4 mg c/8 horas por 10-15 días, luego 4 mg c/12 horas según evolución
3. -Ceftriaxona 2g/d por 7 días EV
4. -Cotrimoxazol forte 1 comp Lunes-Miércoles-Viernes
5. -Calcio 1/día
6. -Tiamina 300 mg c/8 horas EV por 1 día, luego 300 mg/d por 5-7 días EV
7. -Reiniciar tto crónico usual, evitar uso excesivo de analgésicos sedantes (morfina, tramadol, pregabalina)

EXÁMENES Y RESULTADOS

1/7/24
-Alb 3.3
-AU 2.6
-Ca 8.7 Mg 2
-FA 109 Bl 0.4 BD 0.19 BT 0.59 GOT 44 GPT 91 GGT 264
-LDH 577
-Lact 3.5
-PCR 51.6
-Amonio 31
-INR 0.99 TTPA 20
-TSH 0.586 T4L 0.51
-B12 2560 Folato 18.8
-Procal 0.07
-OC nit(+) GB 2-5 GR 2-5 Bact+++
-RPR N/R

-Crea 0.3 MDRD 219.93 Uremia 33
-CKMB 10 CK 26
-PCR 2: 51.4
-Na 136 K 4.1 Cl 102
-Hb 11.3 Leu 9500 Plaq 254000 Seg 86

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo visceromegalia ni masas
-EE: edema +/+, TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico:
-Mental: somnolienta a sopor superficial, confusión moderada, lenguaje hipofluente, sigue ocasionalmente órdenes simples, repite palabras cortas, no nomina, no identifica derecha-izquierda
-PC: CV impresiona conservado por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE impresiona N, mfascie simétrica, sensibildad facial dolorosa impresiona N, nistagmo(-), lengua y úvula centrales, resto normal
-Motor: fuerza ESI M4, ESD M5, EEII M2, RCP extensor bilateral
-Sensitivo: algesia impresiona conservada en las 4 EE
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO